aws Preseed | Innovative Solutions

Businessplan

ANAMNIC

Voice-AI-Lösung für automatisierte medizinische Anamnese

Verfasser: Peter Fehringer, BSc. MSc.

Datum: März 2026

Version: 1.0

1. Executive Summary

Idee für das Produkt

Anamnic ist eine Voice-AI-Lösung zur automatisierten Erhebung medizinischer Anamnesen. Patienten erhalten vor ihrem Arzttermin einen automatisierten Telefonanruf: Die KI führt ein strukturiertes Gespräch zu Krankengeschichte, Beschwerden, Medikation und Allergien. Das Ergebnis ist ein vollständiger Bericht als PDF oder FHIR-Format für die Praxissoftware. Österreichische Ärzte verbringen 51,6% ihrer Arbeitszeit mit Administration [1]. Die Anamnese ist diagnostisch entscheidend: 82,5% der korrekten Diagnosen können allein durch das Anamnesegespräch gestellt werden [15]. Anamnic ermöglicht gründliche Anamnesen ohne zusätzlichen Zeitaufwand für das Fachpersonal. Das Produkt befindet sich in der Konzeptphase; ein demo-fähiger MVP wird bis Q4 2026 angestrebt.

Kompetenzen des Gründers

Peter Fehringer, BSc. MSc. vereint medizinisches und technisches Know-how: BSc. Medizininformatik (Prozesse, Terminologien, Dokumentationsstandards), MSc. Data Science und Engineering (KI/ML, Softwarearchitektur). Die Masterarbeit zum European Health Data Space vermittelte Expertise in Interoperabilitätsstandards (FHIR, HL7, ELGA). Ergänzend: Punktuelle externe Beratung (medizinische Validierung, IT-Recht), Freelancer für Entwicklung bei Bedarf.

Rechtsform und Unternehmensstruktur

Gründung der Anamnic GmbH in Q3 2026. Stammkapital 15.000 EUR (seit GesRÄG 2023: Mindeststammkapital 10.000 EUR [25]), Sitz Niederösterreich (Nähe zu Pilotpraxen, gute Wien-Anbindung). Eigentum initial 100% Gründer, Option für spätere Investorenbeteiligung.

Zielgruppe und USP

Primäre Zielgruppe: Primärversorgungseinheiten (PVE) und größere Praxen. Österreich zählt 100 PVE mit Ausbauziel 133+ und 100 Mio. EUR EU-Förderung [7]. Sekundär: Psychotherapeuten, Krankenhausambulanzen, therapeutische Heilberufe, Reha- und Pflegeeinrichtungen. USP: Einzige sprachbasierte Anamnese-Lösung im DACH-Raum. Der Telefonkanal macht Anamnic von Natur aus barrierearm: Er erreicht auch Patienten ohne Smartphone, mit Sehbehinderungen oder geringen Deutschkenntnissen. Formularbasierte Wettbewerber (Idana, Nelly, CGM) können diese Zugänglichkeit prinzipbedingt nicht bieten.

Kapitalbedarf und Finanzierung

Gesamtkosten des 12-monatigen Vorhabens (Juli 2026 – Juni 2027): 57.270 EUR. Finanziert durch 11.770 EUR Eigenmittel und 45.500 EUR aws PreSeed Förderung. Stammkapital der GmbH: 15.000 EUR (davon 11.770 EUR als Eigenmittelnachweis für das Vorhaben). Ab dem zweiten Halbjahr 2027 erwirtschaftet das Unternehmen erste Umsätze und finanziert sich zunehmend aus laufenden Erlösen.

Nachhaltigkeit und Impact

Gesundheit: Anamnic gibt Ärzten Zeit zurück. Studien zeigen 28–40% Ersparnis durch AI-Dokumentation [11, 12]. Inklusion: Der Telefonkanal ist universell zugänglich, auch für ältere Menschen und Personen mit Einschränkungen.

2. Produkt bzw. Dienstleistung

2.1 Produkt-/Dienstleistungsbeschreibung

Anamnic ist eine Voice-AI-Lösung zur automatisierten Anamnese-Erhebung mit zwei Zugängen:

Telefonbasierter Zugang: Patienten erhalten vor ihrem Termin einen automatisierten Anruf. Die KI führt ein strukturiertes Gespräch zu Krankengeschichte, aktuellen Beschwerden, Medikation und Allergien. Dauer: 5–20 Minuten, je nach Komplexität.

Tablet-basierter Zugang: Für spontane Besuche oder Patienten ohne Vorab-Kontaktierung im Wartezimmer. Dieselbe Gesprächslogik, sofortige Dokumentation. Der Telefonkanal hat strategische Priorität, da er die größte Reichweite bietet.

Kundenproblem: Österreichische Ärzte verbringen 51,6% ihrer Arbeitszeit mit Administration [1]. Die durchschnittliche Konsultationsdauer beträgt nur 5 Minuten [3], davon 29–56% für Anamnese [15]. Gleichzeitig ist die Anamnese diagnostisch entscheidend (82,5% der korrekten Diagnosen). Anamnic ermöglicht gründliche Anamnesen ohne zusätzlichen Zeitaufwand für das Fachpersonal.

Modularer Aufbau: Das System ist modular konzipiert: Basis-Anamnesemodul (MVP), erweiterbar um Fachbereichs-Module (z.B. Psychotherapie, Kardiologie, Orthopädie), Mehrsprachigkeitsmodul und spezifische Exportformate (PDF, FHIR, PVS-Integration).

2.2 Entwicklungsstand bzw. Status Quo des Produkts/Dienstleistung

Das Produkt befindet sich in der Konzept- und Architekturphase. Es liegt kein Prototyp vor; die Entwicklung des MVP ist Kernziel der Gründungsphase. Es gibt derzeit keine erste Kleinserie und keine bestehenden Dienstleistungskunden. Die technische Machbarkeit wurde jedoch validiert: Speech-to-Text für deutschsprachige medizinische Fachbegriffe, konversationelle KI für strukturierte Befragungen und Telefonie-Integration sind verfügbar und erprobt.

MVP-Scope für die ersten zwölf Monate: Telefonie-Integration (z.B. sipgate.io), LLM-basierte Gesprächslogik, medizinische Strukturierung und Dokumentation, PDF- und FHIR-Export sowie ein einfaches Praxis-Dashboard.

Known Hard Problems & Grenzen des MVP: Dialekte und sprachliche Varianz (Fokus auf Hochdeutsch-nahe Sprachführung, Rückfragen bei Unsicherheiten), Multimorbidität und komplexe Krankengeschichten (strukturierte Segmentierung, Übergabe komplexer Fälle), unstrukturierte Erzählungen älterer Patienten (retrospektive Strukturierung, Validierung durch Zusammenfassungen).

Das MVP erhebt und strukturiert Informationen, ersetzt jedoch keine ärztliche Anamnese. Es erfolgt keine medizinische Bewertung, keine Vollständigkeitsgarantie und keine Priorisierung klinischer Relevanz. Diese bewusste Begrenzung reduziert regulatorische Risiken und ermöglicht eine schnelle, realitätsnahe Validierung im klinischen Alltag.

2.3 Impact-bezogene Innovation

Art der Innovation: Anamnic kombiniert mehrere Innovationsebenen:

- Technisch: LLMs für strukturierte medizinische Gespräche in deutscher Sprache, Speech-to-Text mit medizinischem Fachvokabular
- Prozessinnovation: Verlagerung der Anamnese vor den Arzttermin, von synchron (Arzt fragt, Patient antwortet) zu asynchron (KI sammelt vorab)
- Soziale Innovation: Barrierearmer Zugang über den universellen Telefonkanal

Kern der Innovation und Kompetenzen: Die Kernkompetenz liegt im Gründungsteam: BSc. Medizininformatik liefert Domänenwissen (Prozesse, Terminologien, Dokumentationsstandards), MSc. Data Science und Engineering die technische Basis (KI/ML, Softwarearchitektur). Ergänzt durch punktuelle externe Beratung (medizinische Validierung, IT-Recht). Das Kernwissen für die Innovation liegt somit im Gründungsteam; Dritte leisten ergänzende Beratung, keine Kernentwicklung.

Innovationsgrad: International existieren Voice-AI-Lösungen für Medical Scribing (Nuance DAX, Abridge), die jedoch nach dem Gespräch dokumentieren. Formularbasierte Anamnese-Lösungen (Idana, Nelly, CGM AmbulApps) sind etabliert, bieten aber keinen Voice-Kanal. Anamnic ist nach unserer Recherche im DACH-Raum einzigartig in der aktiven, sprachbasierten, vorab-strukturierten Anamnese-Erhebung. Die Nische ist hier komplett unbesetzt [18, 19]. Das adressierte gesellschaftliche Problem (Administrationsbelastung im Gesundheitswesen, Ausschluss nicht-digitaler Patientengruppen) wird durch Anamnic fundamental besser gelöst als durch bestehende formularbasierte Ansätze, da es Sprache statt Schrift nutzt und den Prozess zeitlich vom Termin entkoppelt.

Das System ist modular aufgebaut und kann schrittweise um weitere Fachbereiche erweitert werden. Die Cloud-basierte Architektur ermöglicht skalierbare Nutzung. Offene Standards wie FHIR gewährleisten Interoperabilität und bereiten auf den European Health Data Space ab 2029 vor [10].

2.4 USP, Stärken & Schwächen

Unique Selling Point: Anamnic ist die einzige sprachbasierte Lösung zur automatisierten medizinischen Anamnese im deutschsprachigen Raum. Die entscheidende Abgrenzung liegt nicht nur im Voice-Kanal selbst, sondern in dem, was dieser ermöglicht: Hohe Zugänglichkeit als systemimmanente Eigenschaft (stärkster USP): Kein formularbasierter Wettbewerber kann dies bieten, da Formulare grundsätzlich Lese- und Schreibfähigkeit voraussetzen. Zusätzlich ermöglicht der sprachbasierte Ansatz einfache Mehrsprachigkeit mit minimalem technischem Aufwand, während Formularlösungen jedes Formular einzeln übersetzen und validieren müssen.

Stärken:

- Einzige Lösung im DACH-Raum, die Voice-AI mit strukturierter Anamnese kombiniert [18, 19]. Kein Wettbewerber kann dies replizieren, ohne seinen gesamten Produktansatz zu ändern

- Universelle Zugänglichkeit: Der Telefonkanal erreicht alle Patienten, unabhängig von Alter, Digitalaffinität oder körperlichen Einschränkungen. Ein Gespräch in der Muttersprache reduziert zudem gefährliche Missverständnisse, besonders wenn Patienten in Krankheitssituationen emotional belastet sind
- Wissenschaftlich belegt: 28–40% Zeitersparnis durch AI-gestützte Dokumentation [11, 12]
- Breite Anwendbarkeit: Von der Hausarztpraxis bis zur Rehabilitation
- Regulatorisch schlank: Als Dokumentationssoftware konzipiert, kein Medizinprodukt [20]

Schwächen:

- Kein Prototyp vorhanden: Eigenentwicklung des MVP ist Kernziel der Gründungsphase (Q3–Q4 2026)
- Keine LOIs: Aktive Gespräche mit PVE und Praxen laufen. Ziel: drei LOIs bis Q3 2026
- Einzelgründer: Mitigation durch Freelancer & Berater (punktuell)
- API-Abhängigkeit: Modulare Architektur ermöglicht Migration zwischen Anbietern

Warum sollen Kunden bei Anamnic kaufen? Der Markt teilt sich in zwei Kategorien: Formularlösungen (Idana, Nelly, CGM), die Lese- und Schreibfähigkeit voraussetzen, und Scribing-Tools (Nuance, Abridge), die nach dem Gespräch dokumentieren. Anamnic besetzt als einziger Anbieter den Raum dazwischen: aktive, sprachgeführte Vorab-Anamnese über Telefon. Das ist kein Feature-Unterschied, sondern ein Architekturvorteil: Echte Zugänglichkeit und native Mehrsprachigkeit lassen sich nicht auf Formulare aufsetzen, ohne den gesamten Produktansatz zu ändern.

2.5 Schutzrechte

Schutzrechtsstrategie:

Markenschutz: Die Wortmarke "Anamnic" wird beim Österreichischen Patentamt angemeldet (Klassen 9 und 42). Als Kunstwort, angelehnt an "Anamnese", besitzt sie hohe Unterscheidungskraft. Innerhalb der sechs-monatigen Prioritätsfrist kann bei EU-Expansion die Unionsmarke nachgemeldet werden.

Patente: Derzeit nicht geplant. Die Basistechnologien (LLMs, Speech-to-Text, Telefonie-APIs) sind etablierte Commodity-Dienste. Der Wettbewerbsvorteil liegt in der proprietären Kombination: medizinisch validierte Gesprächslogik, strukturierte Datenextraktion, Integration und regulatorische Architektur.

Eigentum: Alle Schutzrechte liegen beim Gründer bzw. der Anamnic GmbH. Das Know-how steht dem Unternehmen allein zur Verfügung. Kein Drittunternehmen kann die proprietäre Gesprächslogik, die strukturierte Datenextraktion oder die regulatorische Architektur nutzen.

2.6 Wertschöpfungskette & Leistungserstellung

Wertschöpfungskette: Anamnic gliedert sich in die digitale Gesundheits-Wertschöpfungskette zwischen Patienteninteraktion und ärztlicher Konsultation ein. Die Lösung adressiert den Prozessschritt "Anamnese-Erhebung", der bisher synchron und manuell durch das Fachpersonal erfolgte.

Eigenleistung: Produktvision und Roadmap (Kernkompetenz des Gründers), Gesprächslogik und Anamnese-Design (zentrales Differenzierungsmerkmal), Backend-Entwicklung (IP-relevant, mit Freelancer-Unterstützung).

Partnerleistung: LLM-Inferenz über API (EU-souveräne Anbieter, z.B. Mistral, Paris), Speech-to-Text (self-hosted, faster-whisper), Telefonie-Infrastruktur (EU-Anbieter, z.B. sipgate.io), Cloud-Hosting (EU-Rechenzentren, Hetzner, Deutschland).

Produktionskapazitäten: Cloud-basiert, keine eigene Hardware, skalierbar. Beschränkende Faktoren: Gründerkapazität (Einzelgründer) und API-Kosten bei hohem Volumen.

Standort: Niederösterreich. Gründe für die Wahl: Nähe zu Pilotpraxen im ländlichen Raum (wo Ärztemangel besonders spürbar ist), niedrigere Lebenshaltungskosten, Förderprogramme NÖ, gute Wien-Anbindung. Remote-First-Ansatz für künftige Mitarbeiter. Es bestehen keine besonderen Auflagen (Betriebsanlagengenehmigung etc.), da reiner Softwarebetrieb.

Lieferanten: Mistral (Paris) für LLM-Inferenz, sipgate (Düsseldorf) für Telefonie, Hetzner (Deutschland) für Cloud-Hosting. Keine langfristigen Bindungen; modulare Architektur ermöglicht Anbieterwechsel. Alle Lieferanten sind EU-basiert (DSGVO-Konformität).

3. Gesellschaftlicher Mehrwert/Impact

3.1 Themenfeld(er) der gesellschaftlichen Wirkung

Primäres Themenfeld: Gesundheit / Pflege

Das österreichische Gesundheitssystem steht vor einer strukturellen Krise. 51,6% der ärztlichen Arbeitszeit entfällt auf Administration [1]. 20.000 Ärzte gehen in zehn Jahren in Pension, 311 Kassenstellen sind unbesetzt [4]. Die kurze Konsultationsdauer von 5 Minuten korreliert mit erhöhten Krankenhauseinweisungen [3]. Anamnic adressiert dieses Problem direkt, indem es Ärzten und Therapeuten Zeit für die Patientenversorgung zurückgibt.

Sekundäres Themenfeld: Diversität / Gleichstellung / Integration / Inklusion

Digitale Gesundheitslösungen erreichen oft nur technikaffine Zielgruppen. Etwa 23% der Österreicher über 65 nutzen das Smartphone nicht regelmäßig [9]. Menschen mit Lese-/Schreibschwierigkeiten oder Einschränkungen werden von formularbasierten Lösungen strukturell ausgeschlossen, ein Problem, das diese Lösungen aufgrund ihres Grundprinzips nicht beheben können. Hinzu kommt: Rund 25% der österreichischen Bevölkerung haben Migrationshintergrund [26]. Bei Erkrankungen sind Patienten emotional belastet: Formulare in einer Fremdsprache auszufüllen führt zu Missverständnissen und gefährdet die Behandlungsqualität. Der sprachbasierte Ansatz von Anamnic löst beide Probleme systemimmanent: Der Telefonkanal ist universell zugänglich, setzt keine Lese-/Schreibfähigkeit voraus, und ermöglicht Kommunikation in der Muttersprache des Patienten.

3.2 Beschreibung des unmittelbaren positiven Impacts des Vorhabens

Identifizierte Probleme:

Im Bereich Gesundheit/Pflege: Überlastung des Fachpersonals durch Dokumentation, Ärztemangel und fehlende Kapazitäten, kurze Konsultationszeiten mit Qualitätseinbußen. Im Bereich Inklusion: Ausschluss nicht-digitaler Bevölkerungsgruppen von eHealth-Lösungen.

Lösungsansatz:

Anamnic verlagert die Anamnese-Erhebung vor den Arzttermin. Die Voice-KI führt ein strukturiertes Gespräch und erstellt einen vollständigen Bericht. Dadurch wird ärztliche Arbeitszeit freigegeben, die Dokumentationsqualität erhöht und der Zugang für alle Patientengruppen, unabhängig von Digitalaffinität, ermöglicht.

Tiefe und Reichweite des Impacts:

Die Wirkung ist sowohl tief (messbare Zeitersparnis pro Konsultation: 3–5 Minuten) als auch breit (potenziell zehntausende Patienten und hunderte Praxen in Österreich, später DACH). Eine kardiologische Studie mit 762 Patienten [13] bestätigt: Vorab-Anamnesen erreichen signifikant höhere Qualitätsscores (4,2 vs. 2,6 von 5) und verkürzen die Untersuchungszeit.

Quantitative Ziele:

- In den ersten fünf Jahren: mehrere hunderttausend Anamnesen
- Tausende Stunden ärztlicher Zeit für Patientenversorgung zurückgewonnen
- Pro Patient: 3–5 Minuten Zeitersparnis in stark frequentierten Praxen

Wirkungsmessung (geplante Schritte):

- Anzahl durchgeführter Anamnesen (automatisiert im System erfasst)
- Realisierte Zeiteinsparungen (regelmäßige Befragung der Pilotpraxen)
- Nutzungsstatistiken nach Altersgruppen (Auswertung anonymisierter Nutzungsdaten)
- Qualitative Rückmeldungen zur Zugänglichkeit (strukturierte Interviews mit Patienten und Personal)

3.3 Darstellung der Wirkungslogik

Die Wirkungslogik von Anamnic wird anhand der Wirkungstreppe dargestellt:

Stufe 1: Aktivitäten finden statt: Entwicklung und Bereitstellung der Voice-AI-Lösung für medizinische Anamnese. Pilotierung in PVE und Praxen.

Stufe 2: Zielgruppen werden erreicht: Primär: Ärzte, Therapeuten, medizinisches Fachpersonal. Sekundär: Patienten aller Altersgruppen und Fähigkeitsstufen (insbesondere ältere und eingeschränkte Personen).

Stufe 3: Zielgruppen akzeptieren Angebot: Nutzung der Lösung im klinischen Alltag, Integration in bestehende Praxisabläufe, positive Rückmeldungen von Patienten zur Zugänglichkeit.

Stufe 4: Bewusstsein/Fähigkeiten ändern sich: Ärzte und Praxisteams erkennen den Mehrwert einer vorgelagerten, sprachbasierten Anamnese und entwickeln Vertrauen in KI-gestützte Vorab-Dokumentation.

Stufe 5: Zielgruppen ändern Handeln: Praxen verlagern Anamnese-Erhebung systematisch vor den Termin. Ärzte nutzen gewonnene Zeit für längere/bessere Konsultationen oder mehr Patientenkontakte.

Stufe 6: Lebenslage ändert sich: Reduktion der administrativen Belastung des Gesundheitspersonals. Verbesserung der Dokumentationsqualität. Besserer Zugang zur Gesundheitsversorgung für bisher ausgeschlossene Patientengruppen.

Stufe 7: Gesellschaft verändert sich: Beitrag zur Bewältigung des Ärztemangels durch Effizienzsteigerung. Demokratisierung des Zugangs zu digitaler Gesundheitsversorgung. Vorbildwirkung für inklusive Digital-Health-Lösungen.

3.4 Digital & Green Transformation (falls zutreffend)

Anamnic verbindet digitale Transformation mit sozialer Nachhaltigkeit im Sinne der Twin Transition:

Digitale Transformation: Automatisierung eines bisher manuellen, zeitintensiven Prozesses durch KI. Strukturierte Datenerhebung in standardisierten Formaten (FHIR) als Grundlage für den European Health Data Space. Cloud-basierte, skalierbare Lösung ohne Hardware-Investitionen.

Nachhaltigkeit: Papierlose Dokumentation. Kein physischer Vertrieb oder Logistik. Reduzierung unnötiger Arztbesuche durch bessere Vorab-Dokumentation.

4. Markt & Wettbewerb

4.1 Marktgröße und -wachstum

Marktgröße:

- TAM (Total Addressable Market): ~200.000 Nutzer im DACH-Raum × 1.250 EUR/Jahr = ~250 Mio. EUR/Jahr (eigene Berechnung auf Basis der Ärztestatistik der Österreichischen Ärztekammer [4], der Voice-AI-Marktanalyse von Grand View Research [5] und der Krankenhausstatistik der Gesundheit Österreich GmbH [23])
- SAM (Serviceable Addressable Market): ~25.000 Nutzer in Österreich = ~30 Mio. EUR/Jahr (eigene Berechnung auf Basis der Ärztestatistik [4] und der Krankenhausstatistik [23])
- SOM (Serviceable Obtainable Market): 72 Kunden in 4 Jahren × ~2.950 EUR netto = ~228.000 EUR/Jahr (eigene Berechnung auf Basis des geplanten Kundenwachstums gemäß aws Integraler Planung)

Branchengröße Österreich: 52.005 berufsausübende Ärzte (davon ~20.000 niedergelassene) laut Österreichischer Ärztekammer [4], über 10.000 Psychotherapeuten und klinische Psychologen, tausende Therapeuten, 270+ Krankenhäuser mit über 63.000 Betten laut Gesundheit Österreich GmbH [23], 100 PVE (Ausbauziel 133+) laut Plattform Primärversorgung [7].

Marktwachstum und -entwicklung: Voice-AI-Markt wächst mit 37,79% CAGR [5]. Treiber in den nächsten Jahren: Ärztemangel verschärft sich (20.000 Pensionierungen in 10 Jahren) [4], eHealth-Strategie 2024–2030 mit 51 Mio. EUR/Jahr [10], PVE-Ausbau (100 Mio. EUR EU Recovery Fund) [7], ELGA-Ausbau schafft Integrationsinfrastruktur, European Health Data Space ab 2029 [10]. US-Unicorns (Abridge, Ambience, Nuance) mit Milliardenbewertungen zeigen das globale Marktpotenzial [24].

4.2 Zielgruppen & Marktanteil

Primäre Zielgruppe: PVE und größere Praxen

Persona: Dr. Maria Huber, PVE-Leiterin, 45 Jahre, Fachärztin für Allgemeinmedizin. Leitet PVE mit 4 Ärzten und 6 MFA, ~150 Patientenkontakte/Tag. Pain Points: Überlastung, Dokumentationsrückstau, Personalmangel. Entscheidungskriterien: ROI, einfache Integration, Datenschutz. IT-Budget: 500–1.500 EUR/Monat.

Sekundäre Zielgruppe: Psychotherapeuten

Persona: Mag. Thomas Weber, 38 Jahre, niedergelassen mit Kassenvertrag. Pain Points: Viel Zeit für Formulare/Fragebögen statt Therapie. Entscheidungskriterien: Qualitative Entlastung, Flexibilität, Patientenakzeptanz.

Tertiäre Zielgruppen: Krankenhäuser/Ambulanzen (komplexere Entscheidungsstrukturen, höheres Volumen), therapeutische Heilberufe (Erstbefund und Verlaufsdokumentation), Rehabilitationseinrichtungen und Pflegeheime (umfangreiche Sozialanamnesen). Alle Zielgruppen sind B2B.

Regionaler Fokus: Start in Österreich (v.a. Niederösterreich und Wien), DACH-Expansion ab 2028–2029.

Aktueller Auftragsstand: Keine bestehenden Kunden oder Aufträge. Aktive Gespräche mit PVE und Praxen laufen. Ziel: drei LOIs bis Q3 2026, fünf Pilotpraxen bis Q4 2026.

Angestrebter Marktanteil: >30% bei PVE und größeren Praxen in Österreich (langfristig, 3–5 Jahre). Kurzfristig: 72 Kunden bis Ende 2029.

4.3 Wettbewerbsanalyse

Direkte Wettbewerber (digitale Anamnese):

Idana (DE): Marktführer für formularbasierte digitale Anamnese, 1.000+ Praxen, 109–159 EUR/Monat. Stärke: ausgereift, viele Fachbereiche, automatische Score-Berechnung. Schwäche: rein formularbasiert, kein Voice-Kanal.

CGM AmbulApps (DE/AT): 2024 von CompuGroup Medical übernommen, als CGM one Modul in führendes PVS-Ökosystem integriert. Ab 79 EUR/Monat. Zugang zu 6.000+ CGM-Praxen in Österreich, nahtlose PVS-Integration. Schwäche: rein formularbasiert auf iPad, keine aktive Gesprächsführung.

Nelly (DE): Formulare + FinTech, 1.200 Praxen, 65 Mio. EUR Funding, 99–299 EUR/Monat. Schwäche: keine Voice-Komponente, kein Telefonkanal.

Indirekte Wettbewerber (KI-Dokumentation / Medical Scribing):

Tandem Health (SE/DE): KI-Dokumentationsassistent, MDR Klasse IIa, ISO 13485. Aktiver DACH-Markteintritt seit 2025. Löst dasselbe Grundproblem, aber post-hoc statt vorab.

Nuance DAX, Abridge, Ambience Healthcare: US-fokussiert, Milliardenbewertungen, dokumentieren während/nach dem Gespräch. Keine Vorab-Anamnese, kein DACH-Fokus.

Vergleichstabelle der zentralen Features:

Feature	Anamnic	Idana	CGM AmbulApps	Nelly	Tandem Health
Interaktion	Sprache (Telefon)	Formular (Web)	Formular (iPad)	Formular (Web)	Aufnahme (App)
Zeitpunkt	Vor Termin	Vor Termin	Vor Termin	Vor Termin	Während Termin
Telefonkanal	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Barrierearm	Ja (Sprache)	Nein (Lesen)	Nein (Lesen)	Nein (Lesen)	Ja
FHIR-Export	Ja (geplant)	Nein	Ja (CGM)	Nein	Nein
DACH-Präsenz	AT (geplant)	DE, AT	DE, AT	DE	DE, AT
Preis/Monat	150–720 EUR	109–159 EUR	ab 79 EUR	99–299 EUR	k.A.
Medizinprodukt	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja (IIa)

Nachteile von Anamnic aus Kundensicht:

- Kein ausgereiftes Produkt: Anders als Idana (1.000+ Praxen) oder Nelly (1.200 Praxen) befindet sich Anamnic noch in der Konzeptphase. Kunden müssen Vertrauen in ein junges Produkt aufbringen.
- Keine sofortige PVS-Integration: CGM AmbulApps bietet nahtlose Integration in das führende Praxisverwaltungssystem. Anamnic muss diese Integrationen erst aufbauen.
- Keine Score-Berechnung: Idana bietet automatische Berechnung medizinischer Scores (z.B. kardiovaskuläres Risiko). Anamnic verzichtet bewusst darauf, um regulatorisch schlank zu bleiben.
- Einzelgründer: Wettbewerber verfügen über größere Teams und mehr Ressourcen. Dies kann zu langsamerer Feature-Entwicklung führen.
- Neuer Interaktionsmodus: Patienten müssen sich an sprachbasierte Anamnese gewöhnen; die Akzeptanz muss validiert werden. Gleichzeitig ist Sprechen die natürlichste Form der Kommunikation. Gerade ältere Patienten, die mit Smartphone-Formularen Schwierigkeiten haben, sind mit Telefongesprächen vertraut.

Fazit: Die Wettbewerbsanalyse zeigt eine klare Marktlücke: Kein Anbieter im DACH-Raum kombiniert Voice-AI mit strukturierter Vorab-Anamnese. Diese Positionierung eröffnet Anamnic einen Zugang zu Patientengruppen, die von bestehenden Lösungen nicht erreicht werden und schafft damit eine Differenzierung, die nicht durch ein zusätzliches Feature kopierbar ist.

4.4 Markteintrittsbarrieren

- Lange Sales-Zyklen (3–6+ Monate): Mitigation durch kostenlose Pilotphase (30–60 Tage)
- Integration in Praxissoftware: FHIR-Export und PDF als universelle Formate, CGM-Integration als strategisches Ziel
- Datenschutz (DSGVO): DSGVO-konforme Architektur, EU-Hosting, keine US-Dienste
- Regulatorik: Saubere Zweckbestimmung als Dokumentationssoftware (kein Medizinprodukt gemäß MDR 2017/745)

Rechtliche Anwendungsbeschränkungen: Keine Zulassungsbestimmungen als Medizinprodukt erforderlich, da Anamnic keine medizinische Entscheidungsunterstützung bietet. Es werden keine Scores, Risikoklassifikationen oder Diagnosen erstellt. Eine Gewerbeberechtigung ist für den Betrieb als IT-Dienstleister erforderlich. Einfuhr-/Ausfuhrbeschränkungen sind für SaaS-Lösungen nicht relevant.

CGM AmbulApps stellt durch den Vertriebsvorteil des größten PVS-Anbieters die höchste Markteintrittsbarriere dar. Die Differenzierung über Voice-AI und den universellen Telefonkanal ist daher strategisch entscheidend.

4.5 Marktpositionierung

Positionierung: Die einzige barrierearme und mehrsprachige Alternative zu formularbasierter Anamnese. Fokus auf „mehr Zeit für Medizin, weniger für Administration“, und eine Lösung, die alle Patienten erreicht, unabhängig von Sprache, Alter oder Einschränkungen.

Positionierungskreuz:

Achse 1 (horizontal): Interaktionskanal: Formular vs. Sprache. Achse 2 (vertikal): Zeitpunkt: Während/nach Termin vs. Vor dem Termin.

	VOR dem Termin		
Formular	Idana CGM AmbulApps Nelly	**ANAMNIC** *(Alleinstellung)*	**Sprache**
	(herkömmliche Anamnese)	Nuance DAX Abridge Tandem Health	
	WÄHREND/NACH dem Termin		

Kein Wettbewerber besetzt den Quadranten „Sprache + Vor dem Termin“. Anamnic nutzt diese strategische Lücke und adressiert damit gezielt die Patientengruppen, die von formularbasierten Lösungen strukturell nicht erreicht werden.

Kernbotschaften: Für Ärzte: "Strukturierte Anamnese vor dem Termin. Mehr Zeit für Ihre Patienten." Für Praxismanager: "Messbare Effizienzsteigerung. Weniger Dokumentationsrückstau." Für Patienten: "Einfach erzählen, was Sie haben. Keine Formulare, keine App."

5. Marketing & Vertrieb

5.1 Marketingstrategie & Kommunikationskanäle

Marketingstrategie: Fokus auf Direct Sales und Referrals. Ergebnisorientiertes Marketing mit messbarer Zeitersparnis als zentralem Argument. Höhere Marketingausgaben zu Beginn (Bekanntmachung), dann zunehmend Referral-getrieben.

Kommunikationskanäle:

- Direkter Kontakt: Ärztekammer-Events, PVE-Netzwerktreffen, Healthcare-IT-Konferenzen
- Fachpublikationen: Gastbeiträge in Ärzte-Magazinen, Healthcare-IT-Medien
- LinkedIn: B2B-Kommunikation, Vernetzung mit Entscheidern
- Referral-Programm: Zufriedene Kunden empfehlen weiter (ab Vertriebsstart)

Zeitplan der Marketingmaßnahmen:

Zeitraum	Phase	Maßnahme	Kanal	Budget
Q3–Q4 2026	Aufbau	LinkedIn-Profil aufbauen, erste Beiträge	LinkedIn	50 EUR/M
Q3–Q4 2026	Aufbau	Gespräche mit PVE-Netzwerk	Direkt	Reisekosten
Q1–Q2 2027	Pilotphase	Case Study aus Pilotbetrieb erstellen	Fachmedien	250 EUR
Q1–Q2 2027	Pilotphase	Teilnahme an 1–2 Healthcare-IT-Events	Events	500 EUR
Q3–Q4 2027	Vertriebsstart	Gastbeiträge in Ärzte-Magazinen	Fachmedien	250 EUR
Q3–Q4 2027	Vertriebsstart	Referral-Programm starten	Referral	500 EUR
2028	Wachstum	2–3 Konferenzen, LinkedIn Ads, Referrals	Multi	3.000 EUR
2029	Skalierung	Breiteres Event-Portfolio, DACH-Expansion	Multi	5.000 EUR

Marketingbudget: 2026: 250 EUR, 2027: 1.500 EUR, 2028: 3.000 EUR, 2029: 5.000 EUR. Steigend mit wachsender Kundenbasis und Umsatz.

5.2 Vertriebsstrategie

Modell: Direct Sales: Das erklärungsbedürftige Produkt erfordert Demo und persönliche Beratung. Direkter Feedback-Loop essenziell für frühe Produktentwicklung. Kein indirekter Vertrieb über Partner oder Makler in der Anfangsphase.

Vertriebsprozess:

- 1. Awareness (Event, Empfehlung, LinkedIn)
- 2. Interest (Erstes Gespräch)
- 3. Demo (Live-Demonstration)

- 4. Pilot (30–60 Tage kostenlos)
- 5. Evaluation (gemeinsame Auswertung)
- 6. Conversion (bezahltes Abo)
- 7. Referral

Vertriebsvereinbarungen / LOIs: Derzeit keine bestehenden Vertriebsvereinbarungen oder LOIs. Aktive Gespräche mit PVE und Praxen. Ziel: drei LOIs bis Q3 2026. Es bestehen keine Vertriebspartnerschaften.

Start-Use-Case: Telefonbasierte Erstkontakt-Anamnese in PVE: hohes Volumen, akuter Administrationsdruck, Entscheidungsautonomie.

5.3 Preisgestaltung / Erlösmodell

Preisliste:

Paket	Preis/Monat	Zielgruppe	Enthält
Starter	150 EUR brutto (125 EUR netto)	Einzelpraxen	Begrenzte Anrufe, Standard-Logik, PDF-Export
Professional	300 EUR brutto (250 EUR netto)	Praxen mit höherem Volumen	Mehr Anrufe, FHIR, PVS-Integration
Enterprise	720 EUR brutto (600 EUR netto)	PVE, Kliniken	Multi-User, Custom, Priority Support

Laufende Gebühren: Monatliche oder jährliche Abonnements (SaaS-Modell). Bei Jahreszahlung: 10% Rabatt. Keine Einrichtungsgebühr, keine Mindestvertragslaufzeit in der Pilotphase.

Zusätzliche Erlösquellen: Fachbereichs-Module (+49–99 EUR/Monat pro Modul), Mehrsprachigkeit (+29–49 EUR/Monat, dank des sprachbasierten Ansatzes mit minimalem Aufwand umsetzbar, während formularbasierte Wettbewerber hunderte Formulare einzeln übersetzen müssten), Volumen-/Einrichtungstarife für größere Einrichtungen. Kein Wartungsvertrag erforderlich (SaaS, Updates inkludiert).

Durchschnittlicher Umsatz pro Kunde: ~295 EUR brutto/Monat bzw. ~3.540 EUR brutto/Jahr (~2.950 EUR netto/Jahr).

6. Unternehmen und Management

6.1 Informationen zum (geplanten) Unternehmen

- Firmenwortlaut: Anamnic GmbH (geplant)
- Geplantes Gründungsdatum: Q3 2026 (August 2026)
- Rechtsform: GmbH
- Firmensitz: Niederösterreich
- Beteiligungsverhältnisse: 100% Gründer (Peter Fehringer) initial, Option für spätere Investorenbeteiligung
- Stammkapital: 15.000 EUR (seit GesRÄG 2023: Mindeststammkapital 10.000 EUR [25])

Status zur Gründung: Businessplan erstellt, Förderanträge in Vorbereitung, Gespräche mit Pilotpartnern laufen. Gesellschaftsvertrag wird im Zuge der Gründung bei Notar erstellt. Keine bestehenden Verträge. Keine geplanten Änderungen der Unternehmensstruktur in der Anfangsphase.

6.2 Management & (Gründungs)-Team

Peter Fehringer, BSc. MSc., Gründer und CEO

Ausbildung: BSc. Medizininformatik (medizinische Prozesse, Terminologien, Dokumentationsstandards), MSc. Data Science und Engineering (KI/ML, Datenverarbeitung, Softwarearchitektur).

Relevante Vorerfahrung: Masterarbeit zum European Health Data Space. Fundiertes Wissen über Gesundheitsdateninfrastrukturen, Interoperabilitätsstandards (FHIR, HL7, ELGA).

Fehlendes Know-how und Mitigation:

- Medizinische Fachexpertise: Punktuelle Beratung (extern) ab Q3 2026 zur Validierung der Gesprächslogik
- Vertrieb: Nutzung des PVE-Netzwerks für erste Piloten; bei Wachstum: dedizierter Sales-Lead (Personal)
- Kapazität: Fokussierung auf Kernaufgaben, Outsourcing an Freelancer, externe Dienstleister für Steuer/Recht

Entlohnung der Geschäftsführung: Geschäftsführerbezüge während des aws-Vorhabens (12 Monate): 4.000 EUR/Monat (48.000 EUR gesamt, gemäß Integraler Planung). Nach Ende des Förderzeitraums: Beibehaltung auf gleichem Niveau, finanziert aus laufenden Umsätzen. Keine erfolgsabhängigen Gehaltskomponenten in der Anfangsphase.

Der aussagekräftige Lebenslauf des Gründers liegt diesem Businessplan als Anhang bei.

6.3 Organisationsstruktur

Die Organisationsstruktur entwickelt sich in drei Phasen:

Phase 1 (2026): Gründung und MVP:

Peter Fehringer, CEO / Gründer (Vollzeit)	
Produktentwicklung | Geschäftsführung | Vertrieb	
IT-Recht / Medizinrecht *(extern, punktuell)*	Freelancer Entwicklung *(extern, punktuell)*

Phase 2 (ab 2027): Marktreife & Pilotbetrieb:

Peter Fehringer, CEO (Vollzeit)	
Produkt & Technik *(CEO + Freelancer)*	Sales (optional) *(extern oder Teilzeit)*

Phase 3 (ab 2029): Wachstum:

Peter Fehringer, CEO (Vollzeit)		
Entwicklung *1 Teilzeit-Dev* **(besetzt)**	Vertrieb *(geplant)*	Backoffice *(geplant)*

6.4 Kooperationspartnerschaften

Derzeit befinden sich Kooperationspartnerschaften im Aufbau. Geplante Kooperationen:

- Pilotpraxen (PVE und größere Praxen): Aktive Gespräche, Ziel drei LOIs bis Q3 2026
- Medizinische Fachberatung: Punktuelle Beratung zur Validierung der Gesprächslogik
- IT-Recht/Medizinrecht: Externe Beratung für regulatorische Abgrenzung
- Steuer- und Rechtsberatung: Externe Dienstleister

Keine bestehenden LOIs oder Kooperationsverträge zum Zeitpunkt der Antragstellung. Einholung bis Q3 2026 geplant.

7. Status quo des Vorhabens und integrale Planung

7.1 Status quo

Aktueller Stand der Umsetzung:

- Konzeptphase abgeschlossen: Businessplan erstellt, technische Architektur detailliert
- Technische Machbarkeit validiert: Speech-to-Text, konversationelle KI, Telefonie-Integration verfügbar und erprobt
- Marktrecherche abgeschlossen: Wettbewerbsanalyse, Zielgruppenvalidierung, regulatorische Einordnung
- Gespräche mit Pilotpartnern laufen (PVE und Praxen)
- Kein Prototyp vorhanden. Die MVP-Entwicklung ist Kernziel der Gründungsphase
- Keine bestehenden (Test-)Kunden

Wichtigste nächste Schritte: Förderanträge einreichen (Q2 2026), drei LOIs einholen (bis Q3 2026), GmbH gründen (August 2026), MVP-Entwicklung starten (Q3 2026), Demo-fähiger Prototyp bis Q4 2026.

7.2 Integrale Planung

Die integrale Planung orientiert sich an drei Meilensteinen (Details in der beigelegten aws Integralen Planung):

Meilenstein 1 (Voraussetzungen): Förderungsvertrag unterzeichnet, Bankkonto eröffnet, Eigenmittelnachweis erbracht.

Meilenstein 2 (Entwicklung & Validierung, Juli–Januar), höchste Priorität:

- Entwicklung: Demo-fähiger MVP (Telefonie-Integration, LLM-basierte Gesprächslogik, medizinische Strukturierung, PDF-Export, Praxis-Dashboard). Nachweis: Live-Demo eines vollständigen Anamnese-Telefonats mit strukturiertem PDF-Bericht
- Zielgruppenanalyse: Validierung durch direkte Gespräche mit PVE und Praxen. Mindestens 3 LOIs von potenziellen Pilotkunden. Feedback zu Akzeptanz und Zahlungsbereitschaft dokumentiert
- Marketing/Vertrieb: LinkedIn-Unternehmensprofil mit mind. 10 Fachbeiträgen, Teilnahme an 1–2 Healthcare-IT-Events, erste Case Study aus Piloterfahrungen, Vertriebsprozess definiert
- Rechtliches: MDR-Abgrenzung rechtlich abgesichert, Wortmarke „Anamnic“ beim ÖPA angemeldet (Klassen 9, 42), DSGVO-konforme Architektur dokumentiert, IT-Recht-Gutachten eingeholt
- Gründung: Anamnic GmbH gegründet (15.000 EUR Stammkapital), Geschäftsbetrieb aufgenommen, Steuerberatung eingerichtet, Freelancer-Netzwerk aufgebaut
- Impact: Wirkungsindikatoren definiert, Baseline-Erhebung bei Pilotpraxen. KPIs: Anzahl Anamnesen, Zeiteinsparung (3–5 Min/Patient), Nutzungsstatistiken nach Altersgruppen. Weitere Ziele: FHIR-Export implementiert, Integrationskonzept für PVS dokumentiert

Meilenstein 3 (Marktreife & Skalierung, Januar–Juni 2027):

- Produktverbesserung basierend auf Pilotfeedback, Pilotbetrieb mit mindestens 5 aktiven Praxen, erweiterte Funktionen (Mehrsprachigkeits-Grundlage, Tablet-Interface, verbesserte Gesprächslogik)
- Vertriebsstart mit ersten zahlenden Kunden: Mindestens 5 Pilotpraxen in bezahlte Abonnements konvertiert. Marktsegmentierung verfeinert, Preismodell durch Pilotdaten validiert. Referral-Programm konzipiert
- Rechtliches: AGB und Nutzungsbedingungen erstellt, DSFA durchgeführt, AVV mit Cloud-Dienstleistern abgeschlossen. Impact: Erste Impact-Ergebnisse dokumentiert, Wirkungsbericht erstellt. Vorbereitung DACH-Expansion: Regulator. Analyse DE/CH, Produkt-Roadmap für Fachmodule

Wie die Ziele erreicht werden sollen: Eigenentwicklung des MVP durch den Gründer (Vollzeit), unterstützt durch Freelancer. Pilotpartner-Akquise über persönliches Netzwerk und PVE-Kontakte. Iterative Produktentwicklung basierend auf Pilotfeedback.

Was könnte die Zielerreichung hindern: Technische Komplexität (österreichische Dialekte, medizinische Fachsprache), begrenzte Kapazität als Einzelgründer, lange Sales-Zyklen im Healthcare-Bereich (3–6+ Monate), Akzeptanz bei älteren Patienten (muss durch Piloten validiert werden), verzögerte Förderzusage.

8. Erfolgs- und Finanzplanung

8.1 Gründungskosten & Gründungsinvestitionen

Einmalige Gründungskosten:

- GmbH-Gründung (Notar, Firmenbuch): ~1.500 EUR
- Stammkapitaleinzahlung: 15.000 EUR
- Hardware (Computer): 1.500 EUR (Nutzungsdauer 3 Jahre, aliquote AfA im Förderzeitraum: 550 EUR gemäß Integraler Planung)

Die schlanke Kostenstruktur wird ermöglicht durch: Eigenentwicklung, EU-souveränen Tech-Stack mit nutzungsbasierter Abrechnung, Home-Office (keine Raumkosten) und keine MDR-Kosten (als Dokumentationssoftware kein Medizinprodukt).

8.1.1 Laufende Kosten

Die Kostenstruktur für den 12-monatigen Förderzeitraum (Juli 2026 – Juni 2027) ist in der Integralen Planung detailliert dargestellt. Gesamtkosten: 57.270 EUR, finanziert durch 11.770 EUR Eigenmittel und 45.500 EUR aws PreSeed Förderung (3 Tranchen: 18.200 + 18.200 + 9.100 EUR).

2026 (Rumpfjahr Jul–Dez, 6 Monate lt. IP):27.400 EUR. Davon: GF-Bezüge 24.000 EUR (4.000 EUR/Monat × 6), Sachkosten (aliquote AfA) 250 EUR, Drittkosten (Steuer-/Rechtsberatung) 1.150 EUR, sonstige Kosten (Software/APIs/Hosting, Werbung, Telefon) 1.750 EUR, Reisekosten 250 EUR.

2027: ~60.000 EUR. Davon: GF-Bezüge 48.000 EUR (4.000 EUR/Monat × 12), Sachkosten 600 EUR, Drittkosten 2.000 EUR, sonstige Kosten (Software/APIs, Werbung, Telefon) 7.600 EUR, Reisekosten 1.800 EUR. Die ersten 6 Monate (Jan–Jun) gemäß Integraler Planung, H2 2027 auf gleichem Kostenniveau.

2028: Die Kosten werden voraussichtlich im Bereich von 65.000–70.000 EUR liegen, bei gleichbleibenden GF-Bezügen und moderat steigenden Sach- und Marketingkosten durch den wachsenden Kundenstamm. Eine detaillierte Aufschlüsselung erfolgt im Rahmen der laufenden Geschäftsplanung.

2029: Die Kosten werden voraussichtlich im Bereich von 100.000–120.000 EUR liegen, bedingt durch den geplanten ersten Teilzeit-Entwickler, steigende API-Kosten bei wachsendem Volumen und höhere Marketingausgaben für die DACH-Expansion. Eine detaillierte Aufschlüsselung erfolgt im Rahmen der laufenden Geschäftsplanung.

8.1.2 Kapitalbedarf & Finanzierungsquellen

Gesamtkapitalbedarf bis Break-even: 57.270 EUR für den 12-monatigen Förderzeitraum. Finanziert durch: 11.770 EUR Eigenmittel (aus dem Stammkapital von 15.000 EUR) und 45.500 EUR aws PreSeed Förderung. Der verbleibende Stammkapital-Puffer von 3.230 EUR dient als Reserve für unerwartete Kosten. Ab H2 2027 finanziert sich das Unternehmen zunehmend aus Kundenumsätzen.

Kapitalpuffer: Die Integrale Planung weist einen kumulativen Saldo von 0 EUR am Projektende (Juni 2027) aus: Das Vorhaben ist vollständig durchfinanziert. Der verbleibende Stammkapital-Puffer von 3.230 EUR sowie die konservative

Umsatzplanung (kein Pilotumsatz 2026, organisches Kundenwachstum) bieten zusätzliche Reserven.

Finanzierungsstrategie:

- 2026: 11.770 EUR Eigenmittel + 18.200 EUR aws PreSeed (1. Tranche)
- 2027: 27.300 EUR aws PreSeed (2. + 3. Tranche) + laufende Umsätze (70.800 EUR netto) bei ~60.000 EUR Kosten
- 2028+: Voraussichtlich aus wachsenden Umsätzen finanziert. Bei planmäßigem Kundenwachstum wird kumulative Profitabilität im Bereich von ~100.000 EUR Ende 2028 erwartet (grobe Schätzung)

Die aws PreSeed Förderung (45.500 EUR) ist integraler Bestandteil der Finanzierung und ermöglicht die Vollzeit-Entwicklung des MVP im 12-monatigen Vorhabenszeitraum. Die Eigenmittel (11.770 EUR) decken den Eigenanteil gemäß Integraler Planung.

8.1.3 Planbilanz und Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Die detaillierte Plan-Gewinn- und Verlustrechnung, Planbilanz und Liquiditätsplanung für den 12-monatigen Förderzeitraum (Juli 2026 – Juni 2027) sind in der beigelegten aws Integralen Planung (Excel-Datei „Integrale_Planung_-_aws_Preseed_-_Innovative_Solutions_ANAMNIC.xlsx“) enthalten. Die Planung wurde mit einer Excel-basierten Finanzplanung erstellt.

Im Rumpfjahr 2026 (Juli–Dezember) werden keine Umsätze erzielt; die Kosten werden durch Eigenmittel und die erste Tranche der aws PreSeed Förderung gedeckt. Der operative Break-even wird im ersten vollen Geschäftsjahr 2027 erwartet, getragen durch organisches Kundenwachstum und die verbleibenden Fördertranchen. Ab 2028 finanziert sich das Unternehmen voraussichtlich aus laufenden Umsätzen. Die Werte für 2028 und 2029 liegen außerhalb des Förderzeitraums und werden im Rahmen der laufenden Geschäftsplanung konkretisiert.

8.2 Derzeitige Finanzierung und Organisation des Rechnungswesens

Derzeit verfügbare Finanzierungsmittel: 15.000 EUR Stammkapital, davon 11.770 EUR als Eigenmittel für das aws-Vorhaben eingeplant. 45.500 EUR aws PreSeed Innovative Solutions Förderung (beantragt). Kein Betriebsmittelrahmen, keine Bankkredite, keine Besicherung erforderlich.

Buchhaltung: Externe Steuerberatung. In der Anfangsphase familiäre steuerliche Unterstützung.

Auswertung des Rechnungswesens: Monatliche Aufwands-/Ertragsrechnung, jährliche Gewinn- und Verlustrechnung. Quartalsweise Überprüfung der Plan-Ist-Abweichungen.

Liquiditätsplanung: Ja, wird durchgeführt. Monatliche Liquiditätsplanung ist Bestandteil der beigelegten aws Integralen Planung.

Kostenrechnung: Einfache Kostenrechnung nach Kostenarten (Personal, Software, Marketing, Sonstiges). Detaillierung mit wachsendem Geschäftsumfang.

9. Risiken und Herausforderungen

9.1 SWOT-Analyse

Stärken (intern, positiv):

- Kein "AI-Wrapper"-Risiko: Wertschöpfung in Gesprächslogik und Compliance
- First-Mover-Vorteil im DACH-Raum
- Hohe Zugänglichkeit durch Telefonkanal
- Wissenschaftlich validiertes Problem mit belastbarer Evidenz
- Modulare Architektur, regulatorisch schlank

Schwächen (intern, negativ):

- Einzelgründer mit begrenzter Kapazität
- Kein Prototyp vorhanden
- Keine Letters of Intent
- Abhängigkeit von externen API-Anbietern

Chancen (extern, positiv):

- 51 Mio. EUR/Jahr durch eHealth-Strategie [10]
- ELGA-Ausbau schafft Integrationsinfrastruktur
- PVE-Wachstum (100 → 133+ Einheiten) [7]
- Voice-AI-Markt wächst mit 37,79% CAGR [5]
- Ärztemangel erhöht Druck auf Effizienzlösungen

Risiken (extern, negativ):

- Etablierte Wettbewerber könnten Voice-Feature kopieren
- Lange Sales-Zyklen im Healthcare-Bereich (3–6+ Monate)
- Akzeptanz bei älteren Patienten muss validiert werden
- Regulatorische Änderungen könnten Einordnung gefährden

9.2 Risikomanagement

Abgeleitete Strategien und Maßnahmen zur Mitigation der identifizierten Schwächen und Risiken:

- Schwäche "Einzelgründer": Mitigation durch Freelancer und externe Berater bei Bedarf. Ab 2029 erster Teilzeit-Entwickler geplant.
- Schwäche "Kein Prototyp": First-Mover-Vorteil durch schnelle MVP-Entwicklung (bis Q4 2026) nutzen.
- Schwäche "Keine LOIs": Aktive Gespräche laufen, Ziel drei LOIs bis Q3 2026. Kostenlose Pilotphase senkt Einstiegshürde.
- Schwäche "API-Abhängigkeit": Modulare Architektur ermöglicht Migration zwischen Anbietern (z.B. Mistral → Alternative).
- Risiko "Wettbewerber kopieren": Domänenfokus als Schutz vor Commoditisierung. Medizinisch validierte Gesprächslogik und regulatorische Compliance sind nicht leicht kopierbar.

- Risiko "Lange Sales-Zyklen": Kostenlose Pilotphase (30–60 Tage) verkürzt den Entscheidungsprozess.
- Risiko "Akzeptanz ältere Patienten": Validierung durch Piloten mit älteren Patientengruppen. Fallback: Tablet-Interface im Wartezimmer.
- Risiko "Regulatorische Änderungen": Saubere Zweckbestimmung, laufendes Monitoring der MDR-Guidance, rechtliche Beratung. ELGA-Ausbau durch frühe FHIR-Integration als Chance nutzen.

10. Quellenverzeichnis

[1] Österreichische Ärztekammer. (2024). Ausbildungsevaluierung 2024: Ärztliche Arbeitszeit und Administrationsbelastung (Auswertung durch ETH Zürich). Wien.

[2] Doherty, R., McMorrow, R., McGreal, K., & O'Connor, P. (2025). A preliminary conceptual framework of clinical documentation burden. Applied Clinical Informatics, 16(1). https://doi.org/10.1055/a-2751-1896

[3] Irving, G., Neves, A. L., Dambha-Miller, H., Oishi, A., Tagashira, H., Verho, A., & Holden, J. (2017). International variations in primary care physician consultation time: A systematic review of 67 countries. BMJ Open, 7(10), e017902. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-017902

[4] Österreichische Ärztekammer. (2024–2025). Ärztestatistik und Spitalsärzteumfrage. Wien.

[5] Grand View Research. (2023). Voice AI in healthcare market size, share & trends analysis report, 2023–2030. San Francisco.

[6] Hong, G., Lawrence, J., Williams, D., & Mainous, A. G. (2022). The AI will see you now: Patient perceptions of artificial intelligence in healthcare. JMIR Formative Research, 6(7), e37028. https://doi.org/10.2196/37028

[7] Plattform Primärversorgung Österreich. (2025). Standorte und Entwicklung der Primärversorgungseinheiten in Österreich. https://primaerversorgung.gv.at

[8] Austria Wirtschaftsservice (aws) & Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG). (2025). Förderrichtlinien und Programme für Start-ups und F&E-Projekte. Wien.

[9] Statistik Austria. (2023). IKT-Einsatz in Haushalten 2023. Wien.

[10] European Commission. (2024). European Health Data Space (EHDS): Regulation proposal and factsheet. Brussels.

[11] Lim, J. Y., Kim, Y., Park, J., & Lee, S. (2026). How does medical artificial intelligence revolutionize physician productivity? Yonsei Medical Journal, 67(1). https://doi.org/10.3349/ymj.2025.0389

[12] Moura, L., et al. (2025). Hybrid ambient clinical documentation and physician performance. Journal of General Internal Medicine. https://doi.org/10.1007/s11606-025-09979-5

[13] Erden, I., et al. (2024). The impact of automatic history-taking software on clinical documentation quality and workflow. Digital Health, 10. https://doi.org/10.1177/20552076241260155

[14] Sabin, J. E., et al. (2016). 'The time it takes...': How doctors spend their time. Clinical Medicine, 16(4), 320–324. https://doi.org/10.7861/clinmedicine.16-4-320

[15] MedMedia Ärztezeitung. (o. J.). Die Bedeutung des Zeitfaktors in der medizinischen Praxis.

[16] Kontrast.at; MeinBezirk.at. (o. J.). Berichte zu Patientenzahlen in österreichischen Kassenpraxen.

[17] Wiener Praxis; Dorrighi.com; Praxis Leopold. (o. J.). Informationen zu psychotherapeutischen Erstgesprächen.

[18] Eigene Markt- und Regulatorikrecherche. (2025). Analyse der regulatorischen Einordnung (MDR 2017/745, MDCG 2019-11), Wettbewerbslandschaft und

Markenschutzoptionen für Voice-AI-Anamnese-Software im DACH-Raum. Methodik: Systematische Auswertung öffentlich zugänglicher Quellen (EUR-Lex, EUIPO, ÖPA-Datenbank, Unternehmenswebsites der Wettbewerber).

[19] Eigene Marktanalyse. (2025). Analyse von Erfolgsmodellen und Go-to-Market-Strategien für Digital-Health-Start-ups im DACH-Raum. Methodik: Auswertung öffentlich zugänglicher Unternehmensinformationen, Funding-Datenbanken (Crunchbase, dealroom.co) und Branchenberichte.

[20] Medical Device Coordination Group. (2025). MDCG 2019-11 rev.1: Guidance on qualification and classification of software. European Commission.

[21] Österreichisches Patentamt. (2025). Gebührenübersicht Markenanmeldung. Wien.

[22] European Union Intellectual Property Office. (2025). SME Fund 2025 – Call for applications. Alicante.

[23] Gesundheit Österreich GmbH. (2023). Krankenhausstatistik Österreich. Wien.

[24] Öffentliche Unternehmensinformationen zu Abridge, Ambience Healthcare und Nuance/Microsoft (Bewertungen, Marktberichte, Pressematerial).

[25] Gesellschaftsrechtsänderungsgesetz 2023 (GesRÄG 2023). BGBl. I Nr. 179/2023. Inkrafttreten: 1. Jänner 2024. Österreichisches Parlament.

[26] Statistik Austria. (2024). Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Österreich – Ergebnisse der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung. Wien.